

EXAMEN GYNÉCOLOGIQUE

ANAMNÈSE

- Plaintes spontanées
- Grossesse
- Seins (toujours demander si c'est bilatéral):
 - Présence d'une masse d'une boule?
 - Présence d'un écoulement?
 - Présence d'une rougeur?
 - Antécédents personnels concernant les seins (tumeur et mammographie)
 - Histoire familiale de cancer de seins
- Cycle menstruel:
 - Date des dernières règles
 - Régularité des cycles menstruels

STATUS GYNÉCOLOGIQUE

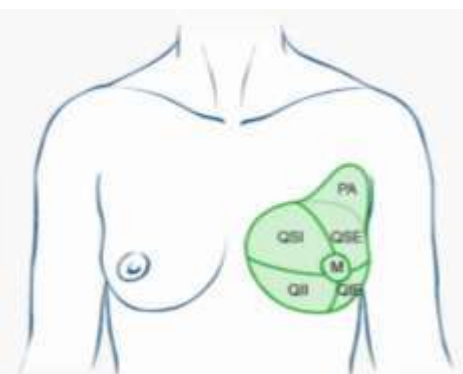
- Demander à la patiente d'enlever son haut et son soutien-gorge afin de dénuder le buste.

EN POSITION ASSISE

- Demander à la patiente de s'asseoir sur la table d'examen et de ne pas bouger.
Demander à la patiente de laisser pendre ses bras le long du corps et de placer ses mains sur ses cuisses afin que la musculature soit détendue.
- Inspecter les seins:
 - Vue globale de la cage thoracique:
 - Observer le thorax: thorax en carène ou en entonnoir, séquelles d'accidents
 - Plaques aérolo-mamellaires supplémentaire: fréquentes
 - Symétrie et morphologie
 - Comparaison du volume :
 - Anisomastie idiopathique : différence physiologique de taille des deux seins.
 - Amastie : développement inexistant
 - Contours :
 - Réguliers et symétrique
 - Rechercher des bosses, des voussures, des ronflements, des aplatissement, des dépression, des rétractions.
 - Peau:
 - Couleur: une rougeur
 - Inflammatoire: seins lourds, tendu et chaude
 - Infectieuse: abcès circonscrit
 - Cancéreuse: lésion étendue et nécrose
 - Texture :

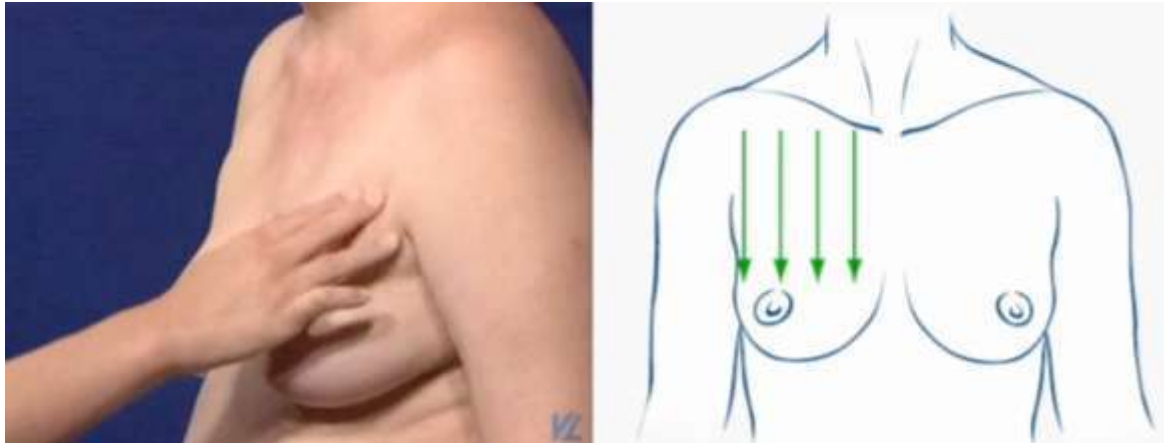


- Vergeture: physiologique
 - Peau d'orange (rigide, pictée, capitonée, ferme): lympho-oedème d'origine cancéreux
 - Cicatrices : à corrélérer avec les antécédents
 - Réseaux veineux : dessin des veines indique une stase
 - Présence de Naevius
 - Mamelons surnuméraires
- Mamelons et l'aréoles: (comparer entre les deux seins)
 - Asymétrie
 - Rétraction: si récente, affection maligne
 - Ecoulement: si unilatéral, affection maligne
 - Qualité de la peau: changement de couleur ou de texture
- Inspecter la mobilité:
 - *Demander à la patiente de lever les bras et placer les mains derrière la nuque.*
 - Observer la mobilité des seins à la recherche d'une voussure ou une rétraction cutané.
- Inspecter sous traction musculaire :
 - *Demander à la patiente de mettre ses mains sur ses hanches et pousser la poitrine en avant. Dans cette position, les muscles pectoraux sont tendus et fixés, ce qui peut mettre en évidence d'autres déformations du sein.*
 - Observer
- Palpation en position assise :
 - Diviser le sein en 4 cadrans virtuels:
 - Cadran supéro-externe prolongé par un prolongement axillaire
 - Cadran inféro-interne
 - Cadran inféro-externe
 - Cadran supéro-interne



- Utiliser la pulpe des trois doigts du milieu

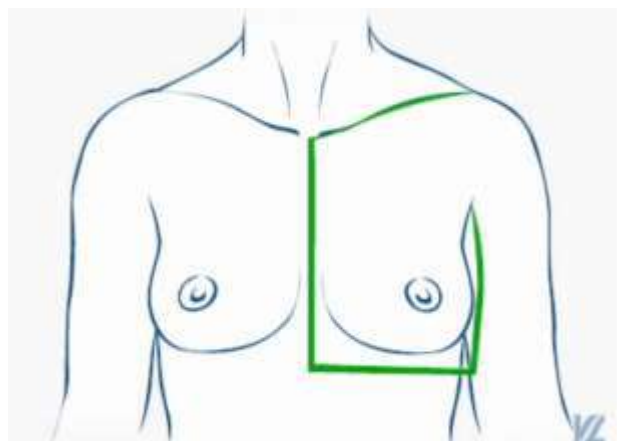
- Palper:
 - -> les cadrans supérieurs (plus facilement palpables car leur peau est fine)
 - -> de gauche à droite
 - -> partir de la clavicule (pour palper le tissu glandulaire épars)
 - -> de haut en bas
 - -> en suivant des lignes verticale virtuelles parallèles



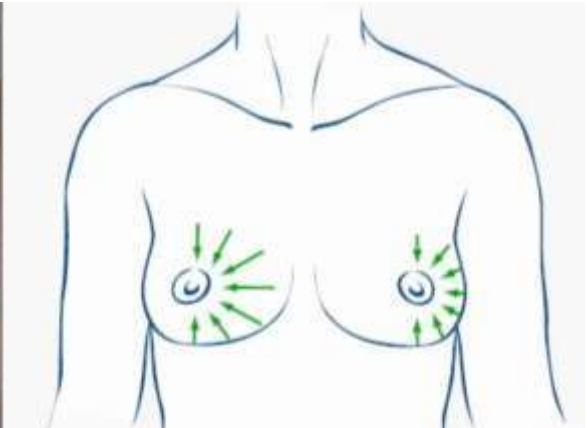
EN POSITION COUCHÉE

En position couchée, la partie inférieure du sein est mieux visible et palpable.

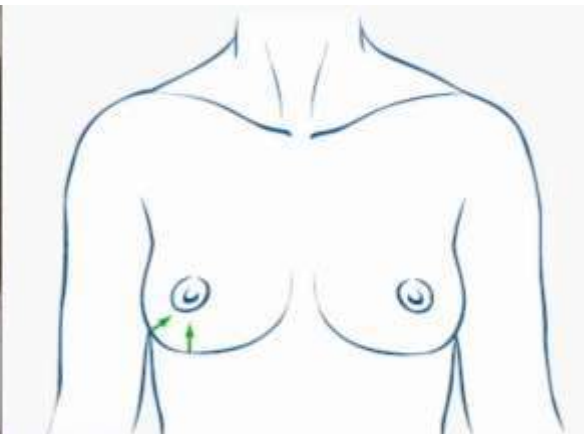
- Inspection :
 - Inspecter en position couchée en faisant attention aux cadrans inférieurs qui sont mieux visibles.
- Palpation:
 - Palper les régions délimitées par:
 - Le sternum
 - La clavicule
 - La zone axillaire postérieure
 - Une ligne virtuelle horizontale à 1 cm en-dessous du plis mammaire
 - Palpation par des mouvements centripètes:
 - Avec les trois doigts du milieu.
 - En réalisant des mouvements centripètes
 - Les moitiés des seins opposées au côté où se trouve l'examineur.



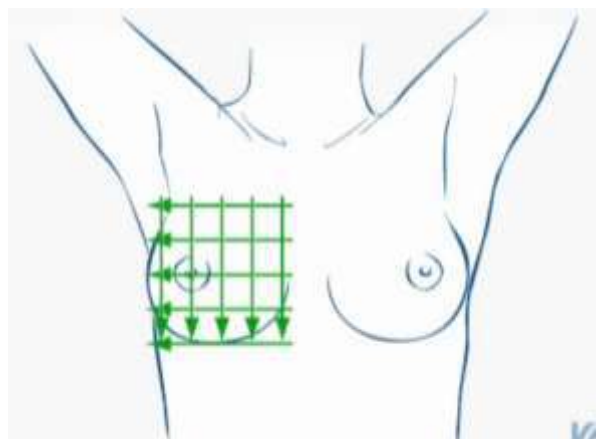
- Si l'examineur est à droite de la patient, palper le bord gauche des sein gauche et du sein droit, en commençant à 12 heure jusqu'à 6 heure.



- Changer de côté.
- Si l'examineur est à gauche de la patiente, palper le bord droit des sein gauche et du sein droit, en commençant à 6h jusqu'à 12 heure.



- Palpation par des mouvements en quadrillage:
 - Avec les trois doigts du milieu.
 - En réalisant des mouvements rectilignes.
 - D'abord transversaux puis en direction cranio-caudale et plus en profondeur.





- Recherche d'un écoulement:
 - **Informez la patiente**
 - Prendre le mamelon entre le pouce et l'index et comprimez le doucement
 - **Préférable: demander à la patiente de le faire.**
 - Observer la présence d'un écoulement.
- Description des ganglions.
 - Localisation
 - Nombres de ganglions touché
 - Taille
 - Consistance
 - Sensibilité
 - Mobilisation



PALPATION DES GANGLIONS LYMPHATIQUES

- Inspection :
 - Observer la région claviculaire:
 - Symétrie des structures
 - Netteté des contours
- Palpation des ganglions péri-vasculaires :
 - Demander à la patiente d'incliner la tête vers le côté à examiner pour détendre le SCM.
 - Poser une main sur l'épaule du côté opposée à celui examiné afin de prendre appui et stabiliser la patiente.
 - Palper l'aire entre la clavicule et les aisselles, le sein et le sternum.
 - Effectuer le même examen de l'autre côté.
- Palpation des ganglions axillaires :
 - Demander à la patiente de poser ses mains sur ses hanches sans exercer de pression afin de détendre les muscles de la région axillaires.



- Palper avec la pulpe des doigts:
 - Entrer depuis devant, derrière le bord externe du muscle grand pectoral.
 - Progresser en direction du creux.
 - La paroi postérieure (il est possible de réaliser cette palpation depuis le dos)
 - Effectuer l'examen de l'autre côté.
- Palpation en position couchée:
 - Demander à la patiente de laisser tomber les bras afin qu'ils soient détendus.
 - Pour examiner le côté droit, saisissez le côté droit de la patiente avec le bras droit, écarter-le et maintenez-le en abduction.
 - Palper des deux côtés.



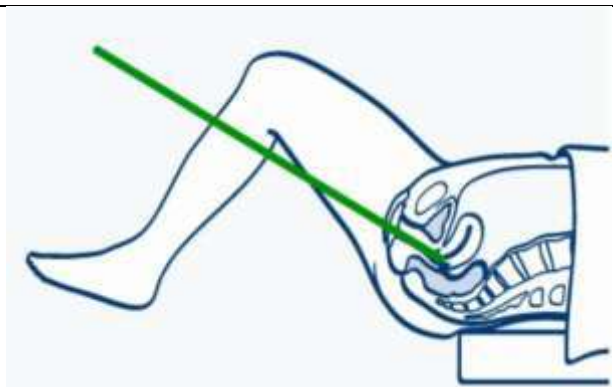
EXAMEN OBSTRÉTIQUE

PRÉPARATION À L'EXAMEN

- Préparer le matériel (stérile si la femme est enceinte).
- Préparer la chaise gynécologique : propreté, confort.

INSTALLER LA PATIENTE

- S'assurer que la patiente n'a pas de prolapsus ou d'incontinence.
- S'assurer que la patiente a vidé sa vessie.
- Inviter la patiente à se déshabiller en dessous de la taille.
- Inviter la patiente à s'asseoir sur la chaise gynécologique (les fesses doivent dépasser le bord de la chaise et à positionner ses jambes (détendues) sur les cales. Les bras doivent être positionnés le long du corps afin que la musculature abdominale ne soit pas contractée.
- Informer à l'avance de chaque étape et préciser ce qu'elle va ressentir.



Importance d'un bon positionnement:

En position correcte, les fesses dépassent le bord de la chaise et l'appui se répartit entre le sacrum et les vertèbres lombaires, entraînant ainsi un effacement de la lordose lombaire. Ainsi le bassin et son contenu sont basculés de manière à aligner le vagin avec l'axe visuel.

En position incorrecte, la patiente s'appuie sur son sacrum et maintient sa lordose lombaire. Le vagin n'est pas aligné avec l'axe visuel.

INSPECTION ET PALPATION ABDOMINALE

- Observer la présence d'une cicatrice (d'une ancienne césarienne).
- Palpation abdominale (commencer au-dessous des côtes car une masse ovarienne peut se situer très haut) à la recherche :
 - D'une masse abdominale
 - D'un globe vésical
 - D'un péritonisme
- Palpation rénale à la recherche d'une douleur des loges rénales
- Palpation des ganglions inguinaux à la recherche d'une adénopathie (petits ganglions = normal)



INSPECTION DES ORGANES GÉNITAUX EXTERNES

- Préparation:
 - Mettre des gants (stériles si la patiente est enceinte)
 - Demander à la patiente d'écarter les cuisses
 - Toucher la cuisse avec le dos de la main pour savoir si la patiente est détendue et constitue un premier contact avant l'inspection.



- Inspection de :



La région pubienne



Les régions inguinales (au-dessus de la symphyse pubienne)



La région anale



Le périnée



La vulve

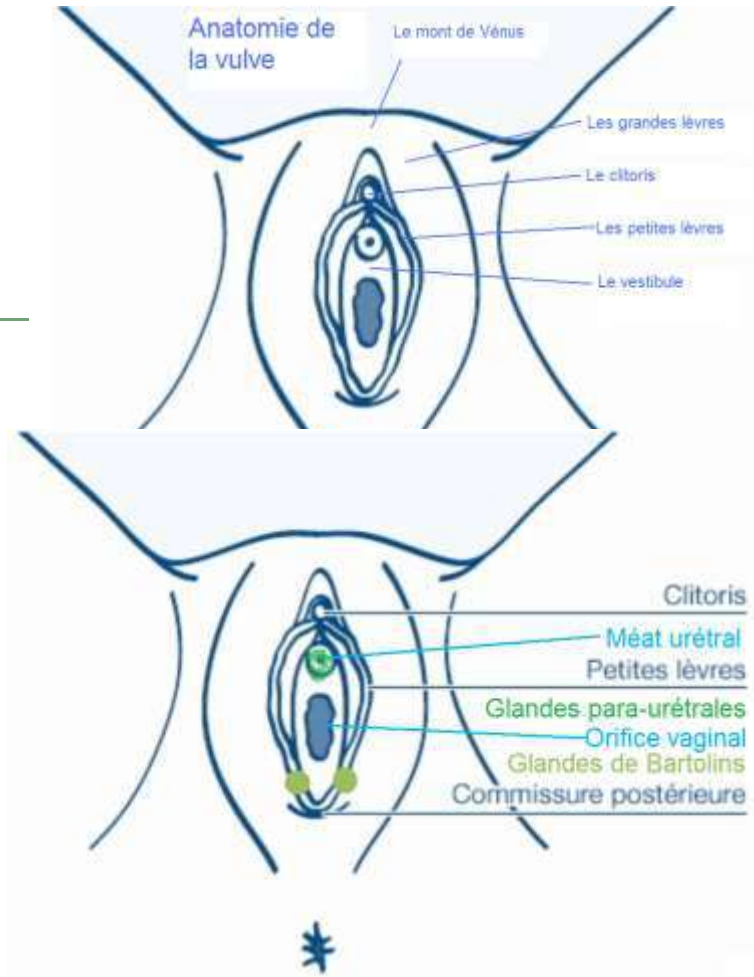


Le vestibule

- Inspection générale :
 - La peau à la recherche: d'abcès, de furoncles, de rougeurs ou d'éruptions cutanées)
 - La pilosité (forme et démangeaisons (poux du pubis ou morpions)

INSPECTION DE LA VULVE

- Evaluer :
 - La symétrie et la taille (des grandes lèvres et du clitoris)
 - Qualité de la peau et la pigmentation
 - La présence de lésions cutanées, de rougeurs, de tuméfactions, de lésions cutanées



- Anatomie :
 - Délimitations:
 - Antéropostérieures : clitoris <-> commissure postérieure
 - Latérales : petites lèvres
 - Contenu:
 - Méat urétral
 - Glandes para-urétrales
 - Orifice vaginal
 - Orifices des glandes de Bartholin
- Écarter les grandes lèvres au milieu de la vulve et les repousser à l'aide de l'index et du majeur en direction craniale.



- Inspecter :
 - Les petites lèvres:
 - Normal : asymétrique, taille variable et présence de glandes sébacées (papules blanches-jaunâtres)
 - Rechercher:
 - Des lésions, des cicatrices, des ulcérations et des différences de couleurs de la muqueuse
 - Des masses et condylomes
 - Le clitoris:
 - Normal: taille de 3-4 mm
 - Rechercher:
 - Des lésions et des ulcérations
 - Taille excessive
 - Le méat urinaire:
 - Normal: sailli en post-ménopause
 - Rechercher du pus ou des signes d'inflammation
- Écarter les grandes lèvres en position sacrale, c'est-à-dire par le bas.
- Inspecter l'ouverture du vagin:
 - Observer les caroncules: restes de l'hymen
 - Rechercher:
 - Lésions des caroncules
 - Une masse ou un signe d'inflammation
 - Un écoulement
- Inspecter la zone autour de la commissure postérieure à la recherche d'une cicatrice (restes d'épisiotomie)
- Inspecter le vestibule sous pression intra-abdominale en position sacrale:
 - Demander à la patiente de pousser comme si elle allait à selles en maintenant son souffle (manœuvre de Valsalva)
 - Rechercher des hernies et des prolapsus (responsable de pertes d'urine entre autre):
 - Hernie vésicale ou urétrale: urétro-cystocèle
 - Prolapsus utérin
 - Hernie intestinal et un prolapsus rectal: entérocele, rectocèle, polypes
 - Attention : l'examen visuel peut être trompeur ! Contrôlez par la palpation avec le doigt.



INSPECTION DE LA RÉGION ANALE

- Rechercher:
 - Masses
 - Cicatrices
 - Fissures
 - Fistules
 - Rougeurs
 - Hémorroïdes

INSPECTION DES GLANDES

- Palpation des glandes para-urétrales en cas d'urétrite:

- Prévenir le patiente de l'introduction de l'index dans le vagin.
- Écarter les grandes lèvres.
- Introduire, dans l'orifice vaginale, l'index (deux phalanges distales) vers

le bas pour éviter la friction avec l'urètre (très sensible).

- Tourner le doigt vers le haut.
- Appuyer délicatement vers le haut.
- Retirer le doigt en maintenant une légère pression sur l'urètre afin d'en exprimer son contenu.



Examen en supination, la pulpe de l'index vers le haut



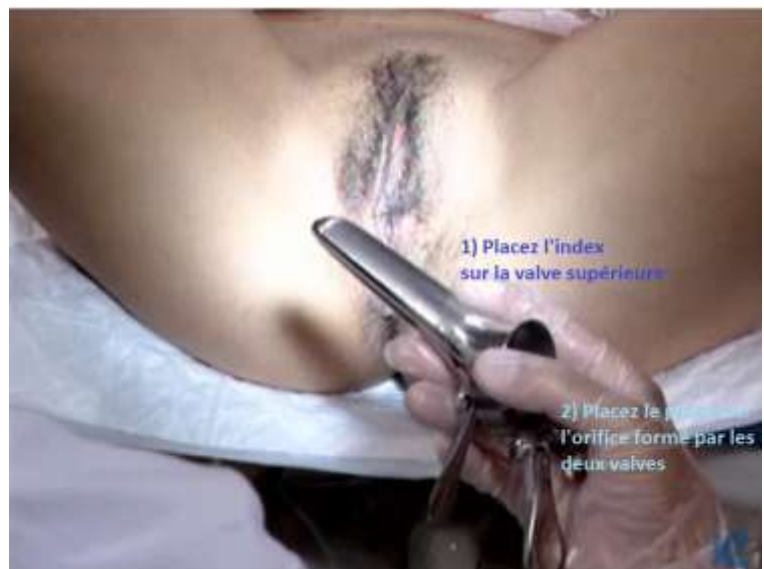
- Palpation des glandes vulvo-vaginales (glandes de Bartholin):

- Prévenir la patiente que l'on va introduire le doigt dans le vagin.
- Placer l'index dans l'orifice vaginal et le pouce sur la grande lèvre (main gauche pour le côté gauche et main droite pour le côté droit).
- Parcourir la grande lèvre avec le pouce en pinçant délicatement à la recherche d'une zone douloureuse ou une tuméfaction. Toute glande palpable est un signe pathologique.



EXAMEN AU SPÉCULUM

- Préparation :
 - Choisir le matériel
 - Un spéculum à conserver dans l'armoire chauffante. Il faut choisir la bonne taille
 - Un flacon de lubrifiant hydrosoluble
 - Une paire de gants non stérilisés
 - Étaler du lubrifiant à l'extrémité distale du spéculum.
- Mise en place du spéculum :
 - Saisir le spéculum avec la main gauche ou la main droite en fonction de la latéralité de l'examineur.



Écarter les grandes lèvres en tirant vers le bas (pour éviter une traction trop forte sur les régions sous-urétrales et clitoridienne) avec l'autre main.



- Tourner le manche du spéculum de 45° et l'apposer sur la commissure postérieure afin d'éviter toucher les régions urétrales et clitoridienne.

- Glisser le spéculum vers l'intérieur en le tournant de 45° et en maintenant une pression sur la paroi postérieure.
- Ouvrir les lames du spéculum afin de les placer devant et derrière le col: manœuvrer jusqu'à ce que le col soit visible sans toucher le (ce qui provoquerait des saignements).
- Maintenir les valves ouvertes grâce à l'écrou.
- Inspecter le col:
 - La position et l'axe (centré)
 - La forme (rond)
 - Le diamètre (2.5 cm)
 - La texture et la couleur de la surface (lisse et rose)
 - La forme de l'ouverture (ronde si nullipare et ovale ou en fente après grossesse)
- Faire un prélèvement
 - Quand faire le prélèvement?
Si suspicion d'infection génitale basse et présence d'un écoulement ou une douleur brûlante ou un prurit.
 - Introduire la spatule d'Ayre entre les lames du spéculum
 - Prélever du matériel dans le cul-de-sac postérieur du vagin.
- Inspecter le vagin lors du retrait du spéculum
 - Dévisser l'écrou tout en maintenant les lames écartées.
 - Retirer lentement le spéculum.
 - Rechercher:
 - Des ulcérations
 - Des kystes
 - Des fistules



PALPATION VAGINALE BIMANUELLE (PERMET D'EXAMINER L'UTÉRUS)

- Préparation:
 - L'examineur est debout.
 - Se munir de gant.
 - Utiliser la main préférentielle: replier le petit doigt et l'annulaire et écarter le pouce. Lubrifier les doigts restant.
 - Écarter les grandes lèvres en tirant vers le bas avec l'autre main.
 - Poser les doigts (index et majeur) sur la commissures postérieures en posant la main à 45° par rapport à la ligne horizontale.
 - Introduire les doigts (index et majeur) en exerçant une pression postérieure (éviter de toucher le clitoris)
 - Explorer la paroi vaginale à la recherche:
 - Nodules
 - Tumeurs
 - Cicatrices
 - Points douloureux



- Arrivé au fond du vagin, tourner la main de 90°, paume contre le haut.



- Passer au-dessous du col afin de palper le cul-de-sac rétro-utérin (normalement vide)
- Évaluer le col:
 - Position: centré par rapport au vagin
 - Consistance: molle (grossesse), dur (cancer)
 - Contours: rond et régulier (irrégulier = cancer)
 - Mobilité: 2-3 cm de déplacement dans tous les côtés (immobile = cancer)
 - Douleur: indolore

- Palpation de l'utérus:
 - Placer la main dans le cul-de-sac postérieur.



Placer la main libre sur l'abdomen de la patiente à mi-distance entre la symphyse pubienne et l'ombilic.

Prévenir la patiente que vous allez déplacer la matrice et lui demander de vous indiquer si c'est douloureux.

- Avec la main vaginal (qui est sous le cul-de-sac), appuyer vers le haut et rapproche ainsi l'utérus vers la paroi abdominal qui est saisi par l'autre main.
- Apprécier :
 - La taille
 - La forme
 - La consistance
 - La mobilité
 - La présence de douleur ou de masses
- Palpation des annexes: ovaires:
 - Palper l'ovaire non douloureux en premier.



◦ Positionner les doigts de la main vaginale dans le cul-de-sac latéral et ramener l'ovaire vers la paroi abdominale.



- Palper l'ovaire avec la main abdominal (l'ovaire est sensible, la patiente peut guider l'examineur) et décrire:
 - Taille (taille d'une noix: 3,5x,2x1,5) (3 ans après la ménopause, l'ovaire n'est plus palpable)
 - Forme
 - Consistance
 - Mobilité
 - Tumeur
 - Douleur

PALPATION RECTO-VAGINAL

Le toucher recto-vaginal complète les informations que vous avez obtenues par l'examen vaginal. Il permet une palpation plus profonde d'un à deux centimètres. Il est particulièrement important lorsque l'utérus est rétro dévié.

- Prévenir la patiente que le vagin et le rectum vont être examinés simultanément et qu'elle aura peut-être l'envie de déféquer.
- A partir de la palpation bi-manuelle, retirer le majeur et l'introduire dans le rectum.
- Inspecter la cloison entre le vagin et le rectum:
 - Epaisseur
 - Présence de tumeurs
 - Présence de nodules
 - Douleurs



PALPATION RECTALE

Lors de l'examen rectal vous pouvez palper l'ampoule rectale, du cul-de-sac postérieur, la face postérieure du col et, pour un utérus rétroversé, aussi une partie du corps utérin.

- Prévenir la patiente que vous allez effectuer un toucher rectal.
- Introduire l'index (avec le majeur) préalablement lubrifié.
- Explorer les parois rectales.
- Retirer le doigt et informer la patiente de la fin de l'examen.

